



Aide-mémoire de l'entretien psychiatrique

à l'attention de l'étudiant cours-bloc

Unité d'Enseignement Clinique Prégradué du Département de Psychiatrie - CHUV
Prof. A. Berney



1. MOTIF DE CONSULTATION	2
2. ELEMENTS ANAMNESTIQUES	2
3. STATUS PSYCHIATRIQUE	3
4. HYPOTHESE DIAGNOSTIQUE ET PROPOSITION THERAPEUTIQUE	4
5. REFERENCES	4
6. ANNEXES	4



1. MOTIF DE CONSULTATION

2. ELEMENTS ANAMNESTIQUES

Anamnèse actuelle

- Explorer les plaintes principales du patient et les symptômes actuels.
- Investiguer le contexte d'apparition du problème et des symptômes : début, durée, intensité, évolution et présence d'évènements déclencheurs.
- Explorer les répercussions du problème et des symptômes dans la vie du patient, notamment dans les sphères sociales, familiales et professionnelles.

Antécédents psychiatriques

Antécédents psychiatriques personnels

- Investiguer les antécédents d'hospitalisation en milieu psychiatrique, de suivi psychiatrique ou psychologique ambulatoire et l'historique des traitements psychotropes.

Antécédents psychiatriques familiaux

- Investiguer la présence de pathologies psychiatriques héréditaires ou non dans la famille.

Anamnèse socioprofessionnelle et familiale

- Profession, activité occupationnelle ou source de revenu (Revenu d'Insertion, Assurance Invalidité, chômage). Activités de la vie quotidienne, loisirs.
- Mode et lieu de vie (seul, en famille, en couple, en institution, sans domicile).
- Entourage social et familial (nature des liens familiaux, nature des liens sociaux, relation sentimentale ou conjugale).

Antécédents médicaux et habitudes

- Rechercher les affections somatiques, les traitements médicaux actuels y compris psychotropes et les allergies.
- Aborder la question de la consommation d'alcool, de tabac et d'autres toxiques.



3. STATUS PSYCHIATRIQUE

Le but du status psychiatrique est de relever les éléments saillants ayant une valeur diagnostique. Tout jugement de valeur est à proscrire. Le status se compose d'une part de ce qui est observé durant l'entretien et d'autre part de ce qui est investigué de manière systématique.

A. PRESENTATION, PSYCHOMOTRICITE ET CONTACT RELATIONNEL

- Corpulence, tenue vestimentaire (soignée, négligée, neutre, excentrique), hygiène, posture, démarche, ralentissement, agitation, mimique.
- Contact et relation

B. TROUBLES COGNITIFS

- Vigilance.
- Orientation sur les 4 modes (temps, espace, quant à la situation, quant à sa personne).
- Attention, concentration, mémoire.

C. PENSEE ET DISCOURS

- Cours de la pensée (accélération de la pensée, fuite des idées, réponses à côté, coqs à l'âne).
- Contenu de la pensée (cohérence, informations, thématique).
- Ton (monotone, exalté), débit de parole (logorrhée, laconisme).

D. DELIRE, TROUBLES DU MOI ET DES PERCEPTIONS

- Idées prédélirantes, idées délirantes (thématique, systématisation, implication affective).
- Déréalisation, dépersonnalisation, pensées imposées.
- Illusions, hallucinations (visuelles, acoustico-verbales, cénesthésiques, olfactives, gustatives).

E. THYMIE / HUMEUR ET AFFECTS

- Humeur abaissée, neutre ou élevée, anhédonie, sentiment d'insuffisance, de culpabilité, affects congruents à l'humeur, discordance affective, labilité affective.

F. ANXIETE

- Tension interne, obsessions, phobies, compulsions.

H. IDEES SUICIDAIRES ET HETEROAGRESSIVITE

G. TROUBLES SOMATIQUES ET DU DYNAMISME

- Troubles du sommeil, de l'appétence, gastro-intestinaux et cardio-respiratoires.

Evaluation du risque auto-agressif ou du potentiel suicidaire selon 3 critères (UDR)**1. Urgence (type et imminence du scénario)**

- Evaluation de la présence d'un scénario suicidaire ou non, degré d'envahissement des idées suicidaires, degré de planification dans le temps du geste suicidaire

2. Danger

- Accessibilité au moyen et létalité du moyen (armes à feu, déféstration, voies ferrées, pendaison, noyade, médicaments).

3. Risque suicidaire (épidémiologique et signaux d'alerte/facteurs précipitants

- Facteurs de risque épidémiologiques : antécédents de tentative(s) de suicide, sexe masculin, trouble psychiatrique, dépendance aux substances, isolement social et familial, événements de vie négatifs, maladie chronique, affection somatique invalidante.
- Signaux d'alerte/facteurs précipitants : pertes, échecs, humiliation/violence, désespoir, rage, comportements à risque, retrait, anxiété, instabilité de l'humeur, agitation.

4. *HYPOTHESE DIAGNOSTIQUE ET PROPOSITION THERAPEUTIQUE*

La procédure diagnostique en psychiatrie est complexe et il est fréquent de ne pas arriver à un diagnostic de certitude suite à un seul entretien. Au terme d'un premier entretien, une hypothèse diagnostique et un diagnostic différentiel sont formulés. Un diagnostic psychiatrique se pose après plusieurs entretiens (2-4 entretiens). Avec les classifications diagnostiques CIM-10 et DSM5, il est fréquent de mettre en évidence plusieurs diagnostics.

Une proposition thérapeutique est formulée en fonction de la première hypothèse diagnostique : poursuite de l'investigation, examen complémentaire, hospitalisation si les soins sont impossibles en ambulatoire et en cas de situation d'urgence, propositions thérapeutiques (psychothérapie, traitement médicamenteux à envisager...).

5. *REFERENCES*

- Le système AMDP, Manuel de documentation de la psychopathologie, Hogrefe, Troisième édition remaniée, 1997.
- Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Dr. Pedro Ruiz MD, Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, Lippincott Williams and Wilkins, 11th edition, 2014.
- Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Kaplan and Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry, Lippincott Williams and Wilkins, 5th edition, 2010. (Traduction française : Kaplan, H.I. et Sadock B.J., Manuel de poche de psychiatrie clinique, Editions Pradel, 2^{ème} édition, 2005.)
- F. Naudet et F. Ferrari, Psychiatrie, Editions Maloine, 2011.
- DSM-V, Cas cliniques, Elsevier, 2016.
- Despland J.-N., Luc Michel, Yves de Roten, Intervention psychodynamique brève : un modèle de consultation thérapeutique de l'adulte, Elsevier Masson, 2010.

6. *ANNEXES*

MÉMENTO DE L'ANAMNÈSE ET DU STATUS PSYCHIATRIQUE + DOCUMENT DE SYNTHÈSE DE L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE



MEMENTO : Anamnèse et status psychiatrique

Anamnèse actuelle

- Plaintes principales du patient et les symptômes actuels
- Contexte d'apparition du problème et des symptômes
- Répercussions du problème et des symptômes dans la vie du patient

Antécédents psychiatriques

- Antécédents d'hospitalisation en psychiatrie, de suivi psychiatrique ambulatoire
- Historique des traitements psychotropes

Anamnèse socioprofessionnelle et familiale

- Profession, activité occupationnelle
- Activités de la vie quotidienne, loisirs
- Mode et lieu de vie
- Entourage social et familial

Antécédents médicaux et habitudes

- Comorbidités somatiques, les traitements médicaux actuels
- Allergies
- Habitudes : consommation d'alcool, de tabac et d'autres toxiques

A. Présentation

âge, tenue, hygiène

Psychomotricité

p.ex. agité, ralenti

A. Contact relationnel

p.ex. collaborant/méfiant/oppositionnel

Conscience morbide

vécu subjectif de la maladie

B. Vigilance

Orientation

Attention, mémoire, concentration

C. Pensée et discours

Cours de la pensée (ralenti, circonscancié, rétréci, digressif, fuite des idées, incohérent, barrages, coq-à-l'âne...)

Contenu de la pensée (cohérence, information, obsessions, ruminations, idées délirantes)

Expression verbale : ton (monotone/ parle fort/chuchote) et débit (logorrhée/laconisme/mutisme)

D. Délire, Troubles du Moi et des perceptions

Idées pré-délirantes, idées délirantes (thématique, systématisation, implication affective)

Déréalisation, dépersonnalisation, pensées imposées

Illusions, hallucinations (visuelles, acoustico-verbales, cénesthésiques, olfactives, gustatives)

E. Thymie

Humeur, affects, symptômes d'accompagnement en faveur d'un épisode dépressif ou maniaque

F. Anxiété

Tension interne, obsessions, phobies, compulsions.

H. Auto-agressivité ou hétéro-agressivité

Idées suicidaires ou pas, scénarisées ou pas de projet

Menaces, comportement agressif ou violent

G. Troubles somatiques et du dynamisme

troubles du sommeil, de l'appétence, gastro-intestinaux et cardio-respiratoires.



Document de synthèse de l'entretien psychiatrique

ELEMENTS ANAMNESTIQUES

Anamnèse actuelle

Antécédents psychiatriques (personnels/familiaux)

Antécédents médicaux et habitudes

Anamnèse familiale et socioprofessionnelle

STATUS

Présentation

âge, tenue, hygiène

Contact relationnel

p.ex. collaborant/méfiant/oppositionnel

Psychomotricité

p.ex. agité, ralenti

Conscience morbide

vécu subjectif de la maladie

Troubles cognitifs

vigilance, orientation, attention, mémoire, concentration

Pensée

Cours de la pensée :

Contenu de la pensée :

Expression verbale :

Délire, Troubles du Moi et des perceptions

Idées délirantes :

Troubles du Moi :

Illusions, hallucinations :

Thymie

Humeur, affects, symptômes d'accompagnement en faveur d'un épisode dépressif ou maniaque

Anxiété

Tension interne, obsessions, phobies, compulsions

Auto- agressivité ou hétéro-agressivité

Idées suicidaires ou non, scénarisées ou non,
Menaces, comportement agressif ou violent

Troubles somatiques et du dynamisme

troubles du sommeil, de l'appétence, gastro-intestinaux et cardio-respiratoires